

Procedimiento ante deterioro y emergencia

CÓDIGO	EME-P01	VERSIÓN	02	FECHA	___ / ___ / ____
--------	---------	---------	----	-------	------------------

Documento base editable para fisioterapeuta independiente en consultorio intramural. Debe adaptarse, adoptarse y acompañarse de evidencias reales antes de evaluar cumplimiento. Responsable del proceso [nombre del profesional].

1 Objetivo y alcance

Actuar oportunamente ante deterioro durante fisioterapia y facilitar continuidad de atención. Este consultorio no se transforma en servicio de urgencias; su respuesta depende de competencias, recursos reales y coordinación con el sistema local.

2 Preparación

Registrar números locales verificados, dirección exacta, acceso al inmueble y servicios de referencia. Revisar medios de comunicación y recursos de primera respuesta definidos según riesgo. Capacitación y equipos deben corresponder a acciones realmente asumidas.

3 Reconocimiento

Suspender terapia ante pérdida de conciencia, dificultad respiratoria marcada, dolor torácico, déficit neurológico súbito, convulsión, trauma o deterioro importante. Reconocer que una señal puede requerir emergencia sin esperar un diagnóstico definitivo.

4 Activación

Asegurar escena y solicitar ayuda. Contactar línea local verificada [completar], informar ubicación, estado, riesgos y teléfono de retorno. Pedir asistencia pertinente y seguir indicaciones del centro regulador, dentro de competencias; no dejar al paciente solo para realizar trámites.

5 Atención inicial

Valorar respuesta y respiración dentro de formación. Aplicar primeros auxilios y, si está capacitado y corresponde, soporte vital básico según entrenamiento vigente y guía local. No administrar medicamentos ni técnicas fuera de autorización. Evitar traslado improvisado si el paciente necesita atención en ruta.

6 Entrega y registro

Entregar identificación, antecedentes relevantes, suceso, tiempos y acciones al personal receptor. Registrar activación, llegada, destino y persona que recibe cuando se conozca. Informar contacto autorizado sin exponer datos innecesarios.

7 Revisión posterior

Reponer recursos usados, revisar evento y barreras, actualizar directorio y realizar ensayo documentado proporcional al riesgo. No declarar simulacros o entrenamiento no ejecutados.

Formatos de registro

Diligenciar con datos reales. Usar No aplica con justificación cuando corresponda. Reproducir cada ficha según necesidad. No incluye campos de firma.

EME-F01 Activación y entrega

Campo	Información
Paciente fecha y hora	_____
Señal y estado inicial	_____
Hora de suspensión y activación	_____
Línea contactada y respuesta	_____
Acciones dentro de competencias	_____
Entrega destino y tiempos	_____
Autor y referencia de autenticación	_____

Lista de verificación interna

EME-F04 • Fecha [completar] • Auditor por nombre [completar]

Registrar C cumple, NC no cumple, NA no aplica o PV pendiente de verificar. C exige evidencia observada; NA exige fundamento. Esta lista orienta la preparación y no reproduce todos los criterios de la autoevaluación oficial.

Punto de control	Estado	Evidencia y observación
Directorio local verificado	_____	_____
Señales de alarma reconocidas	_____	_____
Activación sin demoras administrativas	_____	_____
Acciones dentro de formación	_____	_____
Entrega y tiempos registrados	_____	_____

Registro de hallazgos

Hallazgo y criterio	Acción y responsable	Plazo y eficacia
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Referencias y límites

Base de organización: Resolución 3100 de 2019, manual anexo, criterios generales aplicables y apartado 11.3.1 Servicio de terapias, con modificaciones vigentes. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026. Consulta de fuentes 3 de octubre de 2026. Verificar el instrumento territorial vigente antes de radicar.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576